



【禁忌】
本品不能用于已知对该药的某种成份过敏的患者。
在根除幽门螺杆菌感染的联合疗法中，有中、重度肝肾功能障碍的患者禁用本品，因为目前尚缺乏联合疗法对这类患者疗效及安全性的临床经验。

【注意事项】
当与其他药物联合使用时，每种药物的用药原则均应予以遵守。遇有严重肝功能障碍（肝衰竭）的患者，应定期监测肝脏酶谱的变化，若其测定值增加，必须停止用药。不要使用过期的泮托拉唑。
药品应存放在儿童接触不到的地方。

【孕妇及哺乳期妇女用药】
对孕妇的临床经验有限。动物试验中，在剂量超过5mg/kg时有轻度胚胎毒性作用。无泮托拉唑进入人体乳汁的报道。只有权衡泮托拉唑对母体的益处大于其对胎儿或婴儿的潜在危害时，才可使用本品。

【儿童用药】
目前还没有将之用于儿童的经验。

【老年用药】
参见**【用法用量】**的注意事项。

【药物相互作用】
本品可能减少生物利用度取决于胃内PH值的药物(如酮康唑)的吸收。请注意,这也适用于口服本品之前的短暂时间内所应用的药物。
泮托拉唑的活性成分在肝脏内通过细胞色素P₄₅₀酶系代谢，因此凡通过该酶系代谢的其它药物均不能除外与之有相互作用的可能性。然而对许多这类药物进行专门检测,如卡马西平、咖啡因、安定、双氯芬酸、地高辛、乙醇、格列本脲、美托洛尔、蔡普生、硝苯地平、苯丙香豆素、苯妥英、吡罗昔康、茶碱、华法林和口服避孕药等，却未观察到泮托拉唑与之有明显临床意义的相互作用。
泮托拉唑与同时使用的抗酸药也没有相互作用。
对泮托拉唑与同时服用的抗生素（克拉霉素，甲硝唑，阿莫西林）进行人体动力学研究，未发现有临床意义的相互作用。

【药物过量】
人类应用此药过量后的症状尚不清楚，如果发生药物过量，必须请医生诊治。

【药理毒理】
作用机制 泮托拉唑是苯并咪唑衍生物，通过特异性地与胃壁细胞上的质子泵结合，抑制胃酸分泌。

泮托拉唑在胃壁细胞的酸性分泌小管中被激活，再特异性地与胃酸分泌的最终环节—质子泵（即H⁺,K⁺-ATP酶）结合，抑制胃酸分

泌。抑酸效应呈剂量相关性，能够有效抑制基础、夜间胃酸分泌。与其他质子泵抑制剂和H₂受体拮抗剂一样，泮托拉唑可降低胃酸分泌，刺激胃泌素水平相应升高，这种效应是可逆的。

毒理作用 急性毒理学研究表明，大鼠静脉应用本品后半数致死量（LD₅₀）为390 mg/kg，小鼠为250 mg/kg。慢性毒理学研究显示，泮托拉唑可引起动物（大鼠、小鼠）血液中胃泌素水平上升，并导致胃粘膜形态学改变和胃重量增加，这种效应具有可逆性，随用药终止可自然消失。本品不影响生育，亦无致畸的证据。

【药代动力学】
本品能够有效抑制基础、夜间及24小时胃酸分泌，抑酸效应呈现出剂量相关性。
本品药代动力学呈线性特征，静脉输入或口服10-80 mg后，AUC（浓度时间曲线下面积）和C_{max}（血药浓度峰值）均随剂量的增加而成比例上升。其表观分布容积为0.15 L/kg，清除率为0.1L/h/kg，清除半衰期（t_{1/2}）约为1小时，血浆蛋白结合率为98%。

药物代谢 本品几乎均在肝脏内经细胞色素P₄₅₀酶系代谢，并另有II期代谢的途径。主要代谢物为泮托拉唑去甲基硫酸酯，其大部分（约80%）由肾脏排出，其余由胆汁分泌从粪便中排出。

【贮藏】
30℃以下存放。

【包装】
双铝泡罩，7片或14片/盒

【有效期】
36个月

【执行标准】
进口药品注册标准：JX20150131

【批准文号】
进口药品注册证号：H20160486

【生产企业】
企业名称：Takeda GmbH
地 址：Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz
Germany（德国）
邮政编码：78467
电话号码：+49-7531-84-0
传真号码：+49-7531-84-2474
网 址：http://www.takeda.com

生产地址：Takeda GmbH production site
Oranienburg
Lehnitzstr. 70-98
16515 Oranienburg,
Germany

CHN F.4/0916/6085957 Code: 1636